

PAUSE AR

Nouveautés de la semaine du 26 septembre 2026

2 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

ARRÊT CARDIAQUE, URGENCES & PRÉ-HOSPITALIER Recommandations SFAR et six sociétés partenaires

Organisation de la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières

SFAR et six sociétés partenaires · 21 septembre 2026 · 36 recommandations, méthode GRADE

Sept sociétés publient un référentiel commun sur l'organisation de la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières. Les objectifs annoncés sont d'harmoniser les pratiques, de structurer la réponse et de renforcer la coordination des équipes. Le texte est organisé en quatre champs, du déclenchement de la filière aux spécificités organisationnelles. Les experts ont délibérément limité le nombre de recommandations et écarté les règles de bonne pratique qu'ils considèrent comme connues. Trente-six recommandations ont été adoptées, toutes à accord fort ; aucune recommandation de niveau de preuve élevé n'est rapportée.

En pratique : ce référentiel porte sur l'organisation de la filière plutôt que sur le geste. Il propose un cadre commun que les experts présentent comme adaptable aux différents contextes d'exercice. Ils annoncent viser une meilleure qualité et une meilleure sécurité des soins, ainsi qu'une réduction de la morbi-mortalité liée aux défaillances vitales survenant en établissement de santé. Deux aides cognitives sont mises en ligne avec le texte, l'une pour l'adulte, l'autre pour l'enfant. Le niveau de preuve rapporté est faible : le document se lit comme un accord professionnel, non comme une démonstration.

[Article original](#)

VENTILATION, SDRA & OXYGÉNATION Recommandations SFAR et quatre sociétés partenaires

Prise en charge des voies aériennes de l'adulte au bloc opératoire

SFAR et quatre sociétés partenaires · 24 septembre 2026 · 27 recommandations, méthode GRADE

Cinq sociétés publient un référentiel commun sur la prise en charge initiale des voies aériennes de l'adulte au bloc opératoire. Ce sont la Société française d'anesthésie et de réanimation, le Club d'anesthésie-réanimation en ORL, le Collège d'anesthésie-réanimation en obstétrique, le groupe Facteurs humains en santé et la Société française d'ORL. Le texte couvre trois champs : la prise en charge sans difficulté prévisible, celle des voies aériennes difficiles, prévues ou non, et les facteurs humains avec leurs dimensions organisationnelles. Les vingt-sept recommandations ont toutes été adoptées à accord fort ; une seule atteint un niveau de preuve élevé. Des algorithmes, des aides cognitives et plusieurs autres documents sont mis en ligne avec le texte.

En pratique : ces recommandations donnent le cadre de référence pour l'abord initial des voies aériennes de l'adulte au bloc opératoire. Elles s'accompagnent d'algorithmes et d'aides cognitives téléchargeables, et consacrent un champ entier aux facteurs humains et aux dimensions organisationnelles, briefing et débriefing compris. Le niveau de preuve reste faible : une seule recommandation sur vingt-sept s'appuie sur des données de niveau élevé, et le texte vaut d'abord comme accord professionnel.

[Article original](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : pausear.fr

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.